Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde

Post-it collé sur la page d'agenda

À RETENIR

- Tg = glycoprotéine iodée, prohormone (LT4/LT3) et forme de stockage intracolloïdale des HT et de l'iode.
- Sécrétée **exclusivement** par les cellules thyroïdiennes (normales ou cancéreuses).
- **1 g** de tissu → **0,5 ng** (TSH ↓) ; **1 ng** (euthyroïdie).
- Demi-vie : **2–4 jours**.
- Post-op à **4–6 semaines** : décision thérapeutique pour le FR.
- Temps de doublement **< 1 an** → réfractivité.
- Dosage IRMA (standard CRM 457) ; Tg ultrasensible **0,05 ng** (limite de sensibilité).

I. Définition

- **Tg** : glycoprotéine iodée qui assure sa fonction par sa partie glycosylée ; **prohormone** (pro-LT4–LT3) et forme de stockage des HT et de l'iode (intracolloïdale).
- Sécrétée **exclusivement** par les cellules thyroïdiennes (normales / cancéreuses).
- **1 g** de tissu → **0,5 ng** (TSH ↓) ; **1 g** → **1 ng** (euthyroïdie).
- Demi-vie = **2–4 jours**.

La Tg est fonction de :

1. TSH (niveau de freinage).
2. Anticorps anti-Tg.
3. Masse tumorale.
4. Thyrotoxicose factice et hypothyroïdie congénitale (notes : « factice et H congénitale »).

II. Tg et CDT

1. **Pré-op** : non indiquée, sauf M1 (VPP ↑).
2. **Post-op** : à **4–6 semaines** → décision thérapeutique pour le FR.
3. **Suivi** : sous traitement / après stimulation (défreination).
4. **Liquide de rinçage** des cytoponctions (++) (pas d'interférence des AcTg).
5. Détection précoce de récidive / maladie résiduelle.
6. Temps de doublement **< 1 an** → réfractivité.

III. Dosage

- Technique **IRMA** (standard : CRM 457).
- ARNm de la Tg.
- Tg ultrasensible = **0,05 ng** (limite de sensibilité).

Faux positifs	Faux négatifs
Post-opératoire Post-cure Défaut…	Dédifférenciation Masse ↓ Nécrose AcTg ou anticorps hétérophiles Effet crochet Dosage…

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle quantité de Tg produit 1 g de tissu thyroïdien ?	0,5 ng sous TSH freinée ; 1 ng en euthyroïdie.
2. Demi-vie de la Tg ?	2–4 jours.
3. Quand doser la Tg post-opératoire ?	4 à 6 semaines après la chirurgie.
4. Le dosage pré-opératoire de la Tg est-il indiqué ?	Non, sauf M1 (VPP ↑).
5. Quel temps de doublement prédit la réfractivité ?	< 1 an.
6. Causes de faux négatifs du dosage ?	Dédifférenciation, faible masse, nécrose, AcTg/anticorps hétérophiles, effet crochet.